תיק חקירה של מגפה

אבולה

Ebola virus disease

דוגמה למורה

י' · 20.10.2026

1 הכירו את המחלה

גורם המחלה

נגיף אבולה, ממשפחת הפילו-וירוסים (Filoviridae). יש כמה זנים: זאיר, סודן ובונדיבוגיו. ההתפרצות הנוכחית בקונגו היא של זן בונדיבוגיו.

דגירה ותסמינים

תקופת דגירה של 2–21 ימים. התסמינים הם חום, חולשה, כאבי שרירים, הקאות ושלשולים, ולפעמים דימומים. שיעור התמותה הוא 25%–90%, לפי הזן ולפי הטיפול.

דרך ההדבקה

במקור הנגיף עובר מעטלפי פירות לאדם. מאדם לאדם הוא עובר במגע ישיר בדם ובנוזלי גוף של חולה עם תסמינים, או של נפטר. הוא לא עובר באוויר.

2 איפה ומתי?

גלי התפרצות

לפי הגרף יש שני גלים גדולים: 2014–2016 (מערב אפריקה) ו-2018–2020 (צפון-מזרח קונגו). ב-2026 יש גל חדש בקונגו ובאוגנדה.

סיווג

התפרצות

אזורים שנפגעו

רוב הדיווחים הם מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ומאוגנדה. באזורים האלה יש יערות גשם שבהם חיים עטלפי הפירות, צפיפות במחנות פליטים, ומערכת בריאות חלשה שמקשה על בידוד חולים.

נימוק הסיווג

יש עלייה חדה במספר המקרים באזור מוגבל (מחוזות בקונגו ובאוגנדה). זו לא אפידמיה רחבה כמו ב-2014, ובוודאי לא פנדמיה.

3 קווי ההגנה של הגוף

איך הפתוגן עובר את קו ההגנה הראשון

הנגיף חודר דרך ריריות (עיניים, אף, פה) ודרך פצעים או חתכים בעור, כלומר דרך נקודות התורפה של קו ההגנה הראשון.

חיזוק קו ההגנה הראשון

ציוד מגן מלא לצוותים (כפפות, חלוק, מסכה ומשקפי מגן), שטיפת ידיים, וקבורה בטוחה שבה לא נוגעים בגופה.

קווי הגנה שני ושלישי

בקו השני תאים בולעים מנסים לבלוע את הנגיף, אבל אבולה דווקא מדביקה אותם ומשתמשת בהם להתפשט. בנוסף היא מעכבת את פעולת האינטרפרון. בקו השלישי לימפוציטים מסוג B מייצרים נוגדנים, ומי ששורד מפתח חסינות. הבעיה היא שהתגובה הראשונית לוקחת זמן, והנגיף מתרבה מהר יותר.

4 חיסון וחסינות

האם יש חיסון?

אין חיסון מאושר

חסינות בישראל

אין חיסון שגרה לאבולה בישראל, ואין חסינות באוכלוסייה. אין כאן מושג של סף חסינות עדר, כי אף אחד לא מחוסן.

סוג החיסון / למה אין

לזן זאיר יש חיסון מסוג וקטור נגיפי (Ervebo), שמעורר חסינות פעילה מלאכותית. לזן בונדיבוגיו אין חיסון מאושר, כנראה כי ההתפרצויות שלו נדירות וקטנות, וקשה לבצע ניסויים קליניים כשיש מעט חולים.

5 הסיכון לישראל

הערכת המכ"ם

נמוך

ההערכה שלנו

אנחנו מסכימים. אין טיסות ישירות מקונגו לישראל, הנגיף עובר רק במגע עם חולה שיש לו תסמינים (וחולה כזה בדרך כלל לא טס), ובתי החולים בישראל ערוכים לבידוד. מצד שני, אין חסינות ואין חיסון, ולכן אם יגיע חולה, קו ההגנה היחיד הוא בידוד.

6 השוואה היסטורית

המגפה שבחרנו להשוואה

אבולה במערב אפריקה (2014–2016)

דומה ושונה

דומה: אותה משפחת נגיפים, אותה דרך הדבקה, ואותם אמצעים של בידוד, איתור מגעים וקבורה בטוחה. שונה: ב-2014 לא היה חיסון בכלל, והנגיף הגיע לערים גדולות. היום יש ניסיון מהעבר וחיסון לזן זאיר, אבל לא לזן הנוכחי.

7 הממצאים וההמלצות שלנו

הממצא המפתיע

למרות שאבולה היא אחת המחלות הקטלניות בעולם, הסיכון שתגיע לישראל נמוך. קטלניות ויכולת התפשטות הן שני דברים שונים.

המלצה ברמת הקהילה

צוותים רפואיים יתורגלו בלבישת ציוד מגן ובקבלת חולה חשוד.

המלצה ברמת האדם

מטיילים לאזורי ההתפרצות יימנעו ממגע עם חולים ועם בעלי חיים, ויפנו לרופא אם הם מפתחים חום עד 21 יום אחרי שחזרו.

המלצה ברמת המדינה והעולם

השקעה בפיתוח חיסון לזן בונדיבוגיו, ותמיכה בבדיקות בגבולות באפריקה.

8 מקורות

מקורות

מכ"ם מגפות ישראל ועמוד "חקר מגפות: אבולה" (נתוני WHO)

MedlinePlus: Ebola

WHO Disease Outbreak News, 8 באוקטובר 2026